

- (11) מטבוליזם כללי - עולה
- (12) איברי בטן ואגן - הכול נדחס, דחיקה של הסרעפת, דחיקה כלפי מעלה
- (13) משקל כללי - עולה, בממוצע 12 קילו

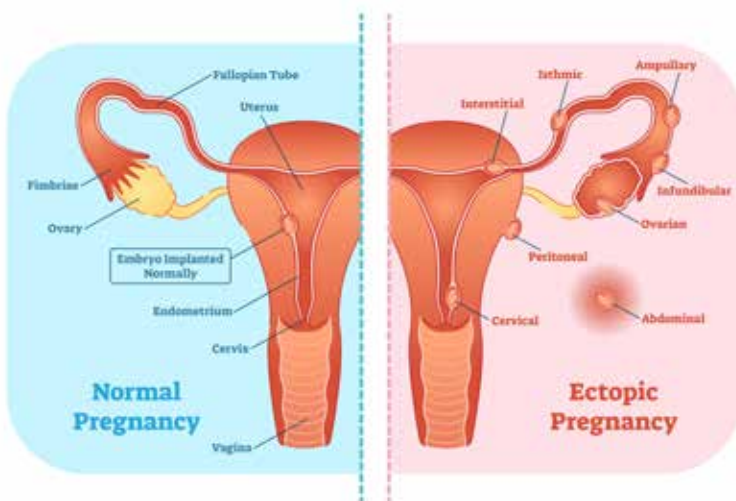
לאגן האישה יש יכולת לזוז ולהתרחב. בזמן לידה מופרש הורמון שגורם לרפיון של הסחוסים באגן כדי שהוא יתגמש ויתרחב.

סיבוכים אפשריים בהיריון

היריון חוץ־רחמי, אקטופי (Ectopic Pregnancy: EP)

היריון חוץ־רחמי פירושו השרשת הביצית המופרית מחוץ לרחם, בדרך כלל בחצוצרה. עם התפתחות ההיריון מחוץ לרחם איברים מסביב עלולים להיחסם או להיקרע. זהו מצב מסכן חיים והוא הסיבה השכיחה ביותר למוות של אישה הרה בטרימסטר הראשון. היריון חוץ־רחמי קורה ב־1.4% מכלל ההריונות, ולכן חשוב מאוד לאבחן מוקדם ולטפל בהתאם.

היריון חוץ־רחמי מתחיל כאשר ביצית מופרית משתרשת מחוץ לרירית הרחם; ב־95% מהמקרים בחצוצרה. גורמי סיכון הם: צלקות מניתוחים או זיהומים קודמים, שימוש בהתקן תוך־רחמי, טיפולי פוריות והיריון חוץ־רחמי קודם. התהליך ההורמונלי בהיריון אקטופי (חוץ־רחמי, ectopic) נמשך כרגיל, כולל שינויים פיזיולוגיים: יש גודש בשדיים, התעבות של הרחם. עם התפתחות ההיריון לחצוצרה אין יכולת התמתחות מרובה, ולכן מתפתחים כאבים חזקים. הסכנות של היריון חוץ־רחמי הן קריעת החצוצרה, דימום תוך־בטני ושוק. לעיתים העובר יתחיל להיווצר בפימבריה (fimbria) שבקצה החצוצרה, ויפול לחלל הבטן. העובר יתפתח על הפריטונאום (קרומ הצפק) או בדופן המעי ועם הזמן יגרמו דימומים תוך־בטניים (איור 16.12).



איור 16.12 היריון חוץ־רחמי, אקטופי (Ectopic Pregnancy: EP)

היריון אקטופי (חוץ־רחמי) בחצוצרה. אפשר לראות את העובר המתפתח בחצוצרה תופס מקום, ככל שיגדל כך יגדלו הכאבים והסיכון לקרע.

סימנים וסימפטומים

- כאבי בטן התקפיים, עוויתיים בבטן התחתונה בצד ימין או שמאל
- בטן קשה ורגישה למגע
- במצב של דם בחלל הבטן, המופריטונאום (hemoperitoneum) יש הקרנה של כאב לכתף כאשר העובר נפלט לחלל הבטן
- לכ־65% מהנשים יהיה דימום וגינאלי לאחר הופעת הכאב. הדימום יהיה שונה בצבעו (כהה יותר), בכמותו (גדולה יותר) ושונה בריחו
- באנמזה יש לברר PID (זיהום באגן אצל נשים, PID: pelvic inflammatory disease), EP (היריון מחוץ לרחם, EP: ectopic pregnancy) בעבר ושימוש בהתקן תוך־רחמי
- בבדיקה פיזיקלית מחפשים סימני הלם

הטיפול

אישה המתלוננת על כאבי בטן ודימום וגינאלי תטופל כמו בהלם גם אם אין סימנים לכך בבדיקה ראשונית.

- מתחילים פינוי לבית חולים ומודיעים על האבחנה החשודה
- במהלך הפינוי דואגים לאבטחת A, B ונותנים חמצן דרך מסכה
- משכיבים את המטופלת בהטיה על צידה השמאלי כדי למנוע לחץ על ה־IVC (הווריד הנבוב התחתון)
- משיגים גישה ורידית ונותנים נוזלים לפי הפרוטוקול
- אין לתת דבר דרך הפה
- מתכוננים לטיפול תרופתי נגד ההקאות
- שומרים על חום גוף
- עוקבים אחר סימנים חיוניים לאורך כל הטיפול והפינוי
- שוקלים חבירה לנט"ן בתיאום עם מוקד מרחבי

הטריאדה הקלאסית של היריון חוץ־רחמי (Ectopic Pregnancy):

(1) כאבי בטן

(2) דימום וגינאלי (menorrhagia)

(3) חוסר וסת, amenorrhea

הפלות

הפלה היא סיום ההיריון לפני שהעובר מסוגל לחיות בכוחות עצמו מחוץ לרחם (לפני שבוע 20 להיריון) או כאשר מסת העובר היא מתחת ל-500 גרם.

הפלות עצמוניות (טבעיות)

- שכיחות ההפלות הטבעיות היא כ-15% מכלל ההריונות.
- ככל שעולה גיל האם - עולה גם שכיחות ההפלות.
- כ-80% מההפלות מתרחשות עד לשבוע ה-12 (הפלה מוקדמת). היתר בין השבועות 13-20 (הפלה מאוחרת).

תהליך ההפלה וסיבותיה

- הביצית המופרית מתנתקת מקיר הרחם.
- התנתקות הביצית כמעט תמיד גורמת לדימום (וזו בדרכ כלל הסיבה שמזמינים אמבולנס).
- הדימום יכול להיות דקיק או שוטף ומלווה בכאב בטן.
- הסיבה להפלה יכולה להיות נעוצה בעובר או באם או ברחם עצמו:

גורמים עובריים

- אנומליות עובריות כמו הפרעה במבנה הגנטי. בכ-80% מכלל ההפלות יש מום בעובר.

גורמים הקשורים לאם

- גורמים זיהומיים - בקטריאליים (דלקת ריאות, כליות), ויראליים (אדמת, הרפס)
- מחלות מטבוליות - סוכרת, היפרתירואידיזם
- מחלות כרוניות - קרדיוסקולרית, לחץ דם
- הפרעות הורמונליות - אי-ספיקת הגופיף הצהוב (פרוגסטרון)
- הפרעות תזונתיות - חסר בחלבונים, מחסור בוויטמינים
- בעיות אימונולוגיות - נוגדנים הפועלים על העובר
- טראומה ישירה לרחם
- הקרנות
- תרופות (משלשלים, עופרת ועוד)
- מתח נפשי